

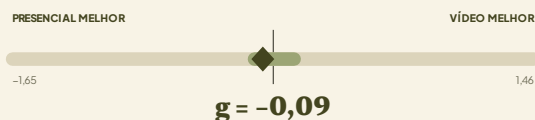
Duas notícias que mudam o alvo da intervenção

Um empate entre vídeo e presencial que vem com ressalva grande, e uma distinção entre dois tipos de agressão que pedem intervenções opostas. Cada uma com o que sustenta e o que não autoriza dizer.



A NOTÍCIA DA CAPA

Vídeo e presencial empatam



Doze ensaios randomizados e 41 tamanhos de efeito, em adultos com dose adequada de tratamento. A faixa clara é o intervalo de predição de 95%: onde um próximo estudo ainda pode cair.

Não autoriza dizer que dá na mesma em qualquer caso. Não cobre crianças, grupo, telefone nem formatos assíncronos, e a base é pequena e predominantemente ocidental.

A SEGUNDA NOTÍCIA

Agressão proativa e reativa não são a mesma coisa

PROATIVA

planejada
ativação baixa
amígdala

REATIVA

impulsiva
ativação alta
pré-frontal

A planejada, de baixa ativação, associa-se a disfunção de amígdala e a falhas de decisão. A impulsiva, disparada por ameaça e com alta ativação simpática, associa-se a déficits de córtex pré-frontal e à leitura de pistas.

Revisão narrativa, não estudo causal. Não autoriza leitura determinista, nem tratar os subtipos como categorias diagnósticas.

TAMBÉM NESTA EDIÇÃO

O efeito dura anos depois da alta

Metanálise com seguimento longo mostra benefício mantido por anos sobre sintomas depressivos. Muda a conversa sobre alta e reforça a prevenção de recaída durante o processo.

MÉTODO

Ler metanálise sem se enganar

Resposta é quantos melhoraram; efeito é quanto acima do controle. Peça sempre a taxa de eventos nos dois grupos, e não só o efeito combinado.

AÇÃO PARA A CLÍNICA

Classifique cada episódio

Antes de escolher intervenção para agressão, classifique o episódio como proativo ou reativo. Se a classificação muda de um episódio para outro, o alvo não é o traço: é o processo daquele contexto.